

摘要：

礼来新型减肥药RETA三期临床数据显示，受试者平均减重28%，近半数超30%，部分患者104周减重85磅。RETA采用三重激动剂机制，优于现有GLP-1药物。礼来最早今年申请FDA上市。该药推动不仅礼来市值逼近万亿美元，同时对餐饮、酒精等消费板块造成了系统性冲击。

礼来公司旗下新一代减肥药retatrutide（简称“RETA”）的最新三期临床数据震学界与资本市场——受试者最高平均减重达体重的28%，约70磅，近半数患者减重超过30%，部分重度肥胖患者在104周内平均减重高达85磅，减重幅度已全面进入此前仅属于减重手术的效果区间。

这一结果被多位未参与试验的独立医学专家称为“有史以来在任何药物试验中见过的最大减重幅度”。礼来表示，最早将于今年向美国食品药品监督管理局（FDA）提交RETA的上市申请。消息公布后，礼来股价持续走强，市值向1万亿美元关口逼近。



礼来公司

NYSE: LLY

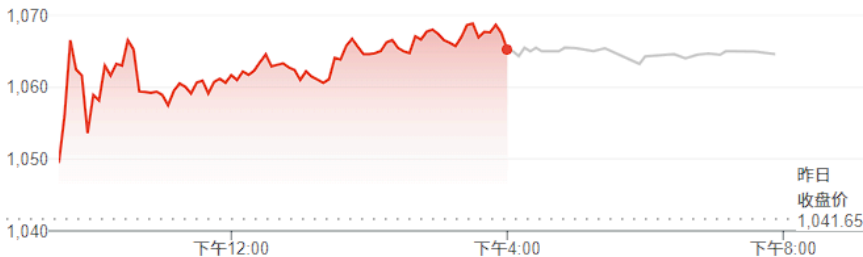
1,065.00 USD

+23.35 (2.24%) ↑ 今天

收盘时间: 5月22日 GMT-4下午7:53 • [免责声明](#)

盘后价 1,064.59 -0.41 (0.039%)

1天 | 5天 | 1个月 | 6个月 | YTD | 1年 | 5年 | 最大



开盘	1,049.81	市值	1.00万亿	股息	0.65%
最高	1,070.34	市盈率	37.84	季度分红金额	1.73
最低	1,047.07	52周高点	1,133.95	52周低点	623.78

RETA的横空出世，不仅标志着GLP-1类药物进入新的进化阶段，更被市场视为一场针对“过度消费经济”的系统性冲击。从餐饮、快餐、酒精到加工食品，多个行业的股价已率先承压。有医学人士甚至预言：

“几年内，肥胖将重新成为罕见病。”

RETA临床数据：减重效果比肩手术

RETA的核心突破在于其“三重激动剂”机制。与此前的GLP-1类药物不同，RETA同时靶向GLP-1、GIP和胰高血糖素三条代谢通路，而礼来现有明星产品Zepbound仅为双重激动剂，靶向GLP-1和GIP两条通路。

据NBC新闻报道，礼来此次公布的三期临床试验共纳入约2300名肥胖或超重患者，试验周期为80周。结果显示，接受最高剂量治疗的患者平均减重28%，约70磅，其中近半数患者减重幅度超过30%。一组重度肥胖患者延长用药至104周后，平均减重达85磅。

TRIUMPH-1 Efficacy Estimand Results ³				
Primary Endpoint at 80 Weeks				
	Retatrutide 4 mg	Retatrutide 9 mg	Retatrutide 12 mg	Placebo
Percent change in body weight at 80 weeks from avg. baseline of 112.7 kg (248.5 lbs; BMI of 40.0 kg/m ²)	-19.0% (-21.4 kg; -47.2 lbs)	-25.9% (-29.2 kg; -64.4 lbs)	-28.3% (-31.9 kg; -70.3 lbs)	-2.2% (-2.5 kg; -5.5 lbs)
Key Secondary Endpoints at 80 Weeks				
Change in waist circumference from baseline of 118.3 cm (46.6 in)	-16.3 cm (-6.4 in)	-21.8 cm (-8.6 in)	-24.1 cm (-9.5 in)	-3.6 cm (-1.4 in)
Percent of participants achieving body weight reduction of ≥25%	27.8 %	52.9 %	62.5 %	2.2 %
Percent of participants achieving body weight reduction of ≥30%	15.3 %	37.9 %	45.3 %	0.5 %
Percent of participants achieving body weight reduction of ≥35%	5.9 %	20.8 %	27.2 %	0.3 %
Pre-specified Extension at 104 Weeks ⁱⁱ				
	Retatrutide 4 mg to MTD ⁱⁱⁱ	Retatrutide 9 mg to MTD ⁱⁱⁱ	Retatrutide 12 mg to MTD ⁱⁱⁱ	Placebo to Retatrutide MTD ⁱⁱⁱ
Percent change in body weight at 104 weeks from avg. baseline of 121.7 kg (268.3 lbs; BMI of 42.8 kg/m ²)	-27.9% (-33.2 kg; -73.3 lbs)	-29.5% (-36.6 kg; -80.7 lbs)	-30.3% (-38.5 kg; -85.0 lbs)	-19.2% (-22.6 kg; -49.9 lbs)

（来源：礼来）

作为参照，Zepbound在72周试验中最高剂量组平均减重约21%，Wegovy在68周试验中最高剂量组平均减重约15%。需要指出的是，上述数据来自各自独立的临床试验。

减重手术通常可帮助患者在一至两年内减轻体重的25%至35%。**RETA的数据已与这一区间高度重叠，令多位专家直呼“游戏规则改变者”。**

杜克大学健康系统人口健康管理办公室高级医疗主任、内分泌学家Dr. Susan Spratt表示：

"这是我在任何药物试验中见过的最大减重幅度，意义重大。"

填补现有GLP-1的疗效空白

RETA的临床价值不仅在于刷新减重纪录，更在于其对现有GLP-1药物无效人群的潜在覆盖。

杜兰大学减重中心医疗主任Dr. Shauna Levy指出，现有GLP-1类药物对于BMI达到35及以上的重度肥胖患者，减重幅度往往不足。

"减重手术可以提供足够的减重效果，但RETA看起来也将成为帮助高BMI患者达到健康体重的有效工具。"

Dr. Spratt进一步补充道，约有10%的患者对现有GLP-1类药物无响应，RETA对这一群体可能具有重要价值。"对于GLP-1无响应者，这款药物可能非常有用。"

在副作用方面，RETA与其他GLP-1类药物类似，常见恶心、便秘和腹泻。

礼来还披露，与安慰剂组相比，RETA组患者出现皮肤异常感觉和尿路感染的报告比例更高。试验退出率高于Zepbound，但与Wegovy相近。

目前，礼来尚未就RETA向FDA提交上市申请，但公司表示最早将于今年启动申报程序。

不止减肥：GLP-1或成“代谢总开关”



RETA的出现，正在推动市场重新评估整个GLP-1类药物的战略价值——其影响已远超单纯的减重范畴。

现有研究显示，GLP-1类药物在降低心脏病风险、改善睡眠呼吸暂停、保护肾功能、减少成瘾行为等方面均有积极信号。而最新的潜在突破来自肿瘤学领域：

克利夫兰诊所将在全球最大癌症学术会议上发布数据，追踪逾1万名癌症患者后发现，GLP-1用药者在乳腺癌、肺癌、结肠癌和肝癌等多种肿瘤类型中，肿瘤进展速度降低38%至50%。研究人员强调，该数据目前仍属早期阶段。

在药物研发层面，制药行业已从双重激动剂迈向三重、四重乃至五重激动剂的竞争，同时靶向多条代谢通路。有观点认为，肥胖药物的研发竞赛，已演变为一场针对人类代谢机制的“军备竞赛”。

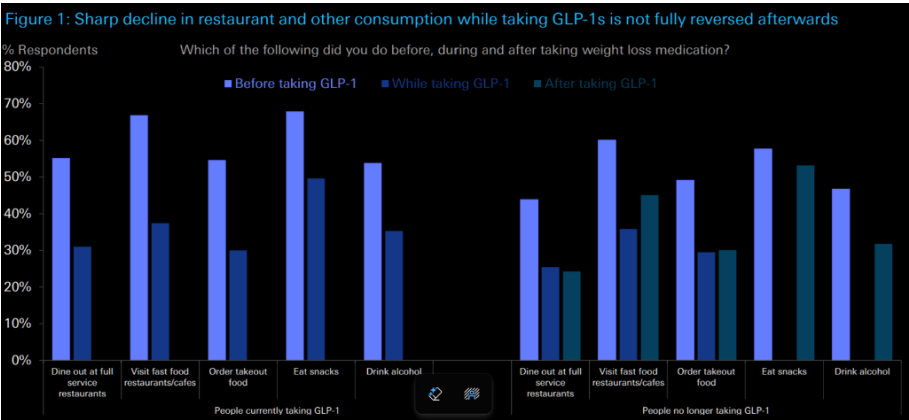
医学人士Dr. Danish对此给出了一个颇具冲击力的预判：“几年内，肥胖将重新被视为罕见病。”

礼来逼近万亿，消费板块承压

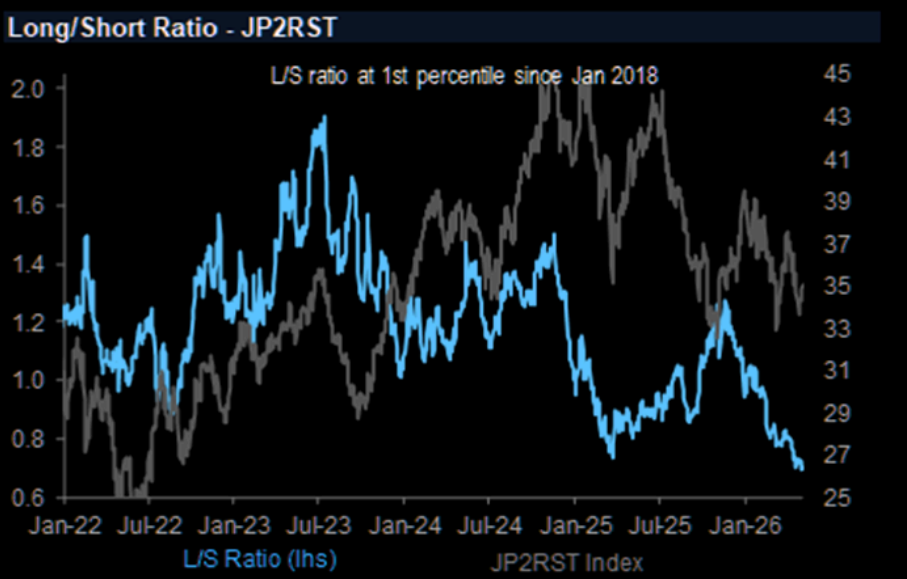
与此同时，RETA的数据浪潮正在资本市场掀起明显的结构性分化。

礼来股价持续受益于RETA预期，向历史新高和1万亿美元市值关口推进。与此同时，礼来基金会管理资产规模已接近1000亿美元。然而，GLP-1类药物的崛起对多个消费行业构成直接冲击。

据德意志银行调研数据，开始服药后，在餐厅就餐的患者比例从55%骤降至31%，光顾快餐店和咖啡馆的比例从三分之二降至37%，点外卖和饮酒的比例也从超过半数降至约三分之一。更值得关注的是，即便停药后，大多数GLP-1用户仍维持了新的饮食习惯——“一旦形成，新习惯基本会延续下去。”



据摩根大通数据，美国餐饮板块整体净表现持续下行，多空比已降至多年低点，处于第一百分位。



酒精行业同样深陷困境。龙舌兰酒品牌Cuervo过去五年股价累计下跌约70%，企业价值自2021年以来蒸发逾七成；帝亚吉欧（Diageo）亦呈现完美下行趋势，市值损失约500亿美元。

另外，加工食品板块也被列为GLP-1浪潮的潜在受害者之一。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码 ➔

免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

👍 534 ★ 收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论

😊 表情 🖼️ 图片

发表评论

5 条评论

 **交易大佬冰**
4小时前 中国广东省

那不是神药了？

现有研究显示，GLP-1类药物在降低心脏病风险、改善睡眠呼吸暂停、保护肾功能、减少成瘾行为等方面均有积极信号。而最新的潜在突破来自肿瘤学领域：

[展开全部](#) ▾

👍 0 ↩️ 回复

 **手机用户**
6小时前 中国山东省

对肝肾损伤是0吗？怎么证明？吃了减肥药肝肾衰竭人死亡谁负责？

👍 0 ↩ 回复



Pixels

5小时前 加拿大

回复

手机用户：

对肝肾影响最大的就是肥胖

👍 0

↩ 回复



MobileUser6642

4小时前 中国上海

回复

手机用户：

几乎任何药都需要肝/肾代谢，但肥胖对健康影响更大。而且，原先有肝肾问题很可能就不能吃这个药

👍 0

↩ 回复



Russia

4小时前 中国安徽省

回复

手机用户：

文盲吧，安全性在一期临床中就检验过了。这都三期了，肝肾损伤几年前就检验过了

👍 0

↩ 回复